# ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL DOLOR LUMBAR

Basado en NICE 2020, VA/DoD 2022 y OMS 2023

## PACIENTE CON DOLOR LUMBAR

## 1. BANDERAS ROJAS EN LA ANAMNESIS

### CAUDA EQUINA
- Retención urinaria
- Incontinencia urinaria
- Incontinencia fecal
- Anestesia en silla de montar

### CÁNCER
- Antecedente de cáncer
- Pérdida de peso inexplicada
- Dolor nocturno o en reposo
- Dolor progresivo
- >50 años con factores de riesgo

### INFECCIÓN
- Fiebre / escalofríos
- Inmunosupresión
- Drogas intravenosas
- Infección reciente (sistémica, urinaria, piel, pulmonar)
- Catéteres (ej. línea central, Foley)

### FRACTURA
- Trauma significativo reciente
- Osteoporosis conocida
- Uso crónico de corticoides
- Edad ≥ 65 años
- Estrés repetitivo (ej. sobreuso)

### ENFERMEDAD INFLAMATORIA (Espondiloartritis axial)
- Inicio < 40 años
- Rigidez matinal > 30 minutos
- Dolor nocturno que mejora al levantarse
- Historia familiar de espondiloartritis, psoriasis, EII, uveítis, etc.
- Buena respuesta a AINE

Si presenta ≥1 bandera roja → continuar con evaluación dirigida.

## 2. EXAMEN FÍSICO

### ¿HALLAZGOS DE ALARMA?

**DÉFICIT MOTOR PROGRESIVO**
- Debilidad progresiva
- Pie caído
- Incapacidad para elevar talones o puntas

**SÍNDROME DE CAUDA EQUINA**
- Tono rectal disminuido
- Anestesia perineal/ genital
- Reflejo anal ausente

**SOSPECHA DE INFECCIÓN / CÁNCER**
- Fiebre
- Mal estado general
- Dolor vertebral localizado intenso

**FRACTURA**
- Dolor a la percusión de apófisis espinosas o costovertebrales

## ¿HAY BANDERAS ROJAS?

### SÍ

#### EVALUACIÓN Y MANEJO INMEDIATO

**Estudios dirigidos según sospecha clínica**
- RMN urgente (preferible)
- TAC (especialmente si sospecha fractura)
- Laboratorios: VSG, PCR, hemograma, hemocultivos, EGO, etc.

**Remisión prioritaria**
- Urgencias / Neurocirugía / Ortopedia / Oncología / Infectología según corresponda

⚠ No retrasar estudios ni remisión.

### NO

#### 3. CLASIFICAR EL DOLOR

**DOLOR LUMBAR INESPECÍFICO**
- Dolor axial lumbar
- Sin irradiación
- Sin déficit neurológico
- ~90–95% de los casos

**RADICULOPATÍA (LUMBORRADICULAR)**
- Dolor irradiado en distribución dermatómica
- Lasègue / elevación de la pierna recta positivo
- Déficit sensitivo
- Déficit motor / hipoarreflexia
- Causas comunes: hernia discal, estenosis

**CLAUDICACIÓN NEUROGÉNICA**
- Dolor/parestesias en MMII al caminar o estar de pie
- Mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante
- Sospecha de estenosis lumbar

#### 4. BANDERAS AMARILLAS (FACTORES DE CRONIFICACIÓN)
- Catastrofización / pensamientos negativos
- Miedo al movimiento (kinesiofobia)
- Ansiedad / depresión / estrés
- Ausentismo laboral / insatisfacción laboral
- Conductas evitativas / inactividad
- Expectativa de discapacidad prolongada
- Problemas sociales / litigio / compensación
- Comorbilidades (obesidad, DM, EPOC, etc.)

Identificar y abordar estas banderas mejora el pronóstico y previene la cronificación.

#### 5. ¿REQUIERE IMÁGENES?

**NO DE RUTINA**

RX simple · TAC · RMN

Si:
- Duración < 6 semanas
- Sin banderas rojas
- Sin déficit neurológico progresivo
- Manejo conservador inicial

**CONSIDERAR IMÁGENES**

Banderas rojas · Déficit neurológico severo o progresivo · Sospecha de cirugía · Procedimiento invasivo planeado · Persistencia > 6 semanas con cambio en conducta terapéutica

Elegir el estudio adecuado según la sospecha clínica: RMN (elección para tejidos blandos y neurología), TAC (mejor evaluación ósea), RX (sospecha de fractura o alineación).

## CLAVES GENERALES
- Realizar historia y examen físico completos.
- Identificar banderas rojas primero.
- Clasificar el dolor para orientar el manejo.
- Evaluar factores biopsicosociales (amarillas).
- Evitar imágenes y tratamientos innecesarios.
- Educación y tranquilidad: evitar cronificación.

## DEFINICIONES ÚTILES
- **Dolor lumbar inespecífico:** dolor entre el margen costal y pliegues glúteos sin enfermedad especifica identificable.
- **Radiculopatía:** disfunción de raiz nerviosa (síntomas motores, sensitivos o reflejos) por compresión o irritación.
- **Claudicación neurogénica:** dolor o fatiga en piernas al caminar que mejora con reposo o flexión lumbar.

## MENSAJE FINAL

La evaluación inicial debe identificar primero causas graves (banderas rojas), luego clasificar el dolor y finalmente detectar factores de cronificación (banderas amarillas) para guiar el manejo más adecuado y seguro.


**REFERENCIAS:**

**NICE (2020).** Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. NICE guideline [NG59]. Última actualización: 11 diciembre 2020.

**VA/DoD (2022).** Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Low Back Pain. Versión 3.0 – 2022.

**OMS (2023).** WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings.


**Nota:** Este algoritmo no reemplaza el juicio clínico. Adaptar a cada paciente y al contexto clínico.

# MANEJO DEL DOLOR LUMBAR Y RADICULOPATÍA EN ADULTOS

*RESUMEN BASADO EN NICE (2020), VA/DoD (2022) y OMS (2023)*

## 1. EVALUACIÓN INICIAL

- Historia y examen físico completos
- Identificar banderas rojas
- Clasificar el dolor: inespecífico / radiculopatía / claudicación neurogénica
- Evaluar factores biopsicosociales (amarillas)
- No solicitar imágenes de rutina

## BANDERAS ROJAS (investigar o remitir)

### CAUDA EQUINA

- Retención urinaria
- Incontinencia urinaria o fecal
- Anestesia en silla de montar
- Déficit neurológico severo/progresivo

### INFECCIÓN

- Fiebre
- Inmunosupresión
- Drogas IV
- Infección reciente (ej. urinaria, pulmonar, piel)
- Catéteres (ej. línea central, Foley)

### CÁNCER

- Antecedente de cáncer
- Pérdida de peso inexplicada
- Dolor nocturno o en reposo
- Dolor progresivo
- >50 años con factores de riesgo

### FRACTURA

- Trauma significativo reciente
- Osteoporosis
- Uso crónico de corticoides
- Edad ≥ 65 años
- Estrés repetitivo (ej. sobreuso)

### ENFERMEDAD INFLAMATORIA

- Inicio < 40 años
- Rigidez matinal > 30 min
- Dolor nocturno que mejora al levantarse
- Historia familiar de espondiloartritis, psoriasis, EII, uveítis, etc.
- Buena respuesta a AINE

## BANDERAS AMARILLAS (riesgo de cronificación)

- Catastrofización / pensamientos negativos
- Miedo al movimiento (kinesiophobia)
- Ansiedad / depresión / estrés
- Conductas evitativas / inactividad
- Ausentismo laboral / insatisfacción laboral
- Problemas sociales / litigio / compensación
- Expectativa de discapacidad prolongada
- Comorbilidades (obesidad, DM, EPOC, etc.)

## 2. MANEJO ESCALONADO Y CENTRADO EN LA PERSONA

### A. MANEJO NO FARMACOLÓGICO (DE PRIMERA LÍNEA PARA TODOS)



**EDUCACIÓN Y ASESORAMIENTO**

- Explicar el buen pronóstico
- Promover mantenerse activo y autónomo
- Evitar reposo en cama



**EJERCICIO TERAPÉUTICO**

- Programa estructurado, individualizado y supervisado
- Fortalecimiento, flexibilidad, resistencia y control motor
- Preferido para LBP y radiculopatía



**ACTIVIDAD Y AUTOCUIDADO**

- Mantener actividad física y laboral según tolerancia
- Adaptar tareas, ergonomía y hábitos saludables



**TERAPIAS MANUALES**

- Manipulación espinal (puede considerarse)
- Masaje (beneficio a corto plazo)
- Movilización



**TERAPIAS PSICOLÓGICAS**

- Terapia cognitivo conductual (TCC) Terapia cognitiva
- Mindfulness / reducción de estrés basada en mindfulness
- Terapia operante / respondente (como complemento)

Combinar intervenciones según preferencias, necesidades y respuesta del paciente. Enfatizar adherencia, metas funcionales y retorno a actividades significativas.

### B. MANEJO FARMACOLÓGICO (SEGÚN NECESIDAD Y SEVERIDAD)



**1ª ELECCIÓN**

Paracetamol
AINEs orales

- Considerar riesgo GI, renal y cardiovascular



**2ª ELECCIÓN / DOLOR PERSISTENTE**

Antidepresivos (ISRSN: duloxetina) o Antiepilépticos (gabapentina / pregabalina)

- Útiles en dolor neuropático (radiculopatía)



**OPIOIDES**

- No de primera línea
- Considerar solo si dolor severo y refractario
- Usar la dosis más baja posible y por el menor tiempo posible; reevaluar riesgo/beneficio



**RELAJANTES MUSCULARES**

- Beneficio a corto plazo (≤ 2 semanas)
- Considerar somnolencia y dependencia



**OTRAS OPCIONES**

- AINEs tópicos para dolor localizado
- Capsaicina tópica puede considerarse

### C. INTERVENCIONES INVASIVAS (SOLO EN CASOS SELECCIONADOS)



**INYECCIONES EPIDURALES**

- Considerar en radiculopatía con dolor persistente que no responde a manejo conservador por ≥ 6 semanas



**BLOQUEOS FACETARIOS / RADIOFRECUENCIA**

- Evidencia limitada.
- Considerar en dolor facetario confirmado.



**CIRUGÍA**

- Solo en radiculopatía con:
  - Déficit neurológico progresivo
  - Síndrome de cauda equina
  - Dolor refractario con correlación imagenológica y falla de manejo conservador ≥ 6–12 semanas



**ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA**

- Considerar en síndrome de cirugía fallida de columna o dolor neuropático refractario

## 3. SEGUIMIENTO Y REEVALUACIÓN



- Revaluar en 4–6 semanas
- Monitorear dolor, función, estado psicológico y participación en actividades



- Ajustar plan según respuesta y preferencias del paciente



- Reevaluar si aparecen nuevas banderas rojas o empeoramiento neurológico



- Enfocar en objetivos funcionales: participación, calidad de vida y retorno a actividades significativas

## PRINCIPIOS CLAVE COMPARTIDOS

- Enfoque centrado en la persona y toma de decisiones compartida.
- Educación y autocuidado como base del manejo.
- Actividad física y ejercicio como pilar terapéutico.
- Evitar intervenciones innecesarias (reposo, imágenes y tratamientos sin indicación).
- Abordar factores biopsicosociales para prevenir cronificación.
- Usar la menor intensidad de tratamiento efectiva.
- Seguridad del paciente y minimización de riesgos.

## ¿CUÁNDO SOLICITAR IMÁGENES?

- No de rutina en las primeras 6 semanas.
- Solicitar si hay banderas rojas.
- Radiculopatía severa o progresiva.
- Sospecha de patología específica.
- Planificación de procedimiento invasivo o cirugía.
- No mejoría tras manejo conservador y afectación significativa que cambie la conducta terapéutica.

## MENSAJE FINAL

La mayoría de los casos de dolor lumbar son inespecíficos y mejoran con manejo conservador activo, educación y apoyo psicosocial. Identificar tempranamente banderas rojas y factores de riesgo de cronificación es clave para un mejor pronóstico.

## PRONÓSTICO

- 90–95% de los episodios de dolor lumbar mejoran en las primeras 4–6 semanas.
- La recurrencia es común; el enfoque debe ser en prevención y manejo a largo plazo.

## REFERENCIAS


- NICE (2020). Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management (NG59).
- VA/DoD (2022). Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Low Back Pain.
- OMS (2023). Guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings.


**NOTA:** Este resumen no reemplaza el juicio clínico. Adaptar a cada paciente y al contexto clínico.

# RECOMENDACIONES INTEGRADAS PARA EL MANEJO DE LUMBALGIA (AGUDA, SUBAGUDA Y CRÓNICA)

Basado en: VA/DoD Clinical Practice Guideline 2022, NICE Guideline NG59 2016 (actualizada 2020) y OMS Directriz 2023 sobre lumbalgia crónica primaria.

| | INTERVENCIÓN | RECOMENDACIÓN INTEGRADA | FUERZA PRÁCTICA | COMENTARIOS CLAVE |
|---|---|---|---|---|
| A FAVOR | **Educación + autocuidado + permanecer activo** | Debe estar en todos los pacientes. Explicar benignidad frecuente, curso fluctuante, evitar reposo, retorno funcional. | ALTA (utilidad alta / riesgo bajo) | Núcleo de todas las guías. Mejora función y reduce miedo-evitación. |
| | **Estratificación de riesgo (p. ej., STarT Back)** | A favor para decidir intensidad del manejo. NICE la recomienda desde el primer contacto. | ALTA | Permite personalizar cuidado y focalizar recursos en alto riesgo. |
| | **Ejercicio terapéutico** | A favor. No hay una modalidad claramente superior; elegir según preferencias, capacidad y adherencia: fuerza, aeróbico, control motor, Pilates, yoga, funcional. | ALTA | Intervención con mejor evidencia para dolor y función a corto y largo plazo. |
| | **Terapia cognitivo-conductual o abordaje piscológico** | A favor si dolor persistente, miedo-evitación, catastrofismo, ansiedad/depresión, discapacidad o baja autoeficacia. | ALTA | Reduce discapacidad y mejora retorno a la actividad. |
| | **Programas físico-psicológicos combinados** | A favor en dolor persistente o mala respuesta inicial. | ALTA | Mayor efecto que intervenciones aisladas. |
| | **Retorno al trabajo/actividad** | A favor. Objetivo funcional central, no esperar analgesia completa. | ALTA | Disminuye discapacidad, recurrencia y costos. |
| A FAVOR CONDICIONAL / SELECTIVA | **Terapia manual / manipulación / masaje** | A favor condicional, solo como parte de paquete con ejercicio ± enfoque psicológico. No como manejo aislado. | MODERADA | Puede dar alivio a corto plazo, pero beneficios no se mantienen sin ejercicio activo. |
| | **AINEs** | A favor condicional en cursos cortos, dosis mínima efectiva, evaluando riesgo gastrointestinal, renal y cardiovascular. | MODERADA | Primera opción farmacológica si se requiere, con evaluación de riesgo. |
| | **Duloxetina / IRSN** | Puede considerarse en lumbalgia crónica seleccionada, especialmente con comorbilidad afectiva o dolor persistente. No es primera línea universal. | MODERADA-BAJA | Evidencia de beneficio modesto; individualizar. |
| | **Acupuntura / punción seca** | Divergente: NICE no la recomienda; otras guías la consideran condicional en algunos contextos. En institución, no priorizarla si recursos limitados. | BAJA / CONTROVERTIDA | Beneficio variable; priorizar intervenciones activas. |
| | **Infiltraciones epidurales** | No de rutina para lumbalgia axial. Puede considerarse en radiculopatía seleccionada con correlación clínica-imagen y dolor incapacitante. | SELECTIVA | Evidencia de alivio a corto plazo en ciática; considerar riesgos. |
| | **Radiofrecuencia facetaria** | Selectiva, solo si sospecha facetaria, manejo conservador fallido y bloqueos diagnósticos positivos. | SELECTIVA | Para dolor facetario confirmado; beneficios a mediano plazo. |
| | **Cirugía** | No para lumbalgia inespecífica. Considerar en déficit neurológico progresivo, cauda equina, estenosis/radiculopatía refractaria con correlación anatómica. | SELECTIVA | Reservada para indicaciones claras; mejor evidencia en radiculopatía con compresión. |
| EN CONTRA (no recomendada) | **Imágenes rutinarias** | En contra si no hay banderas rojas ni cambio esperado de conducta. NICE: no imagen rutinaria en escenario no especializado. | ALTA | Retrasa manejo, aumenta costos y no mejora desenlaces. |
| | **Reposo en cama** | En contra. Favorece discapacidad y miedo al movimiento. | ALTA | Mantener actividad según tolerancia. |
| | **Fajas/corsés/ortesis plantares/ zapatos rocker** | En contra para lumbalgia inespecífica. NICE no los recomienda. | ALTA | No hay beneficio clínico relevante. |
| | **Tracción** | En contra. NICE y OMS la ubican como intervención de bajo valor. | ALTA | No mejora función ni dolor a mediano/largo plazo. |
| | **TENS, ultrasonido, interferenciales, PENS** | En contra para uso rutinario. NICE no los recomienda. | ALTA | Beneficio clínico mínimo o nulo. |
| | **Paracetamol como monoterapia** | En contra como tratamiento principal de lumbalgia. Beneficio clínico pobre. | ALTA | Puede considerarse como coadyuvante si se requiere. |
| | **Gabapentinoides para ciática/ lumbalgia** | En contra. NICE: no ofrecer gabapentinoides, antiepilépticos, corticoides orales o benzodiacepinas para ciática por falta de beneficio y daño. | ALTA | Riesgo de efectos adversos sin beneficio significativo. |
| | **Opioides** | En contra en lumbalgia crónica y ciática crónica. Si se usan en dolor agudo severo, que sea excepcional, corto y con plan de retiro. | ALTA | Riesgo de dependencia, sobredosis y cronificación del dolor. |
| | **Benzodiacepinas** | En contra. Riesgo de dependencia, sedación y bajo beneficio. | ALTA | Evitar en lumbalgia y ciática. |
| | **Corticoides sistémicos** | En contra para ciática/lumbalgia rutinaria. | ALTA | No mejora desenlaces funcionales; riesgo de efectos adversos. |
| | **Relajantes musculares** | No de rutina; podrían considerarse muy corto plazo en lumbalgia aguda seleccionada, evitando adultos mayores y riesgo de sedación. | BAJA / SELECTIVA | Evidencia limitada; usar con cautela y por pocos días. |
| | **Cannabis, suplementos, hierbas** | Evidencia insuficiente o débil; no priorizar en protocolo institucional. | BAJA | Falta de evidencia de eficacia y seguridad a largo plazo. |

**Nota:** La fuerza práctica se refiere al balance entre beneficio esperado y certeza/consistencia de la evidencia para guiar decisiones clínicas.

# ESCALA STarT Back

## Cuestionario para la estratificación de riesgo del dolor lumbar

Consta de 9 ítems que evalúan factores físicos, psicológicos y sociales.

| LAS 9 PREGUNTAS | | CÓMO PUNTUAR | |
|---|---|---|---|
| | | Sí | No |
| 1 |  En las últimas 2 semanas, ¿ha tenido molestias en el cuello o en los hombros? | 1 | 0 |
| 2 |  En las últimas 2 semanas, ¿ha tenido dolor que se ha extendido por el brazo o la pierna (por debajo de la rodilla)? | 1 | 0 |
| 3 |  En las últimas 2 semanas, ¿ha tenido dolor en varias partes del cuerpo (por ejemplo, cuello, hombros, espalda, brazos o piernas)? | 1 | 0 |
| 4 |  En las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido bajo de ánimos, deprimido o sin esperanza? | 1 | 0 |
| 5 |  En las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido poco interés o placer en hacer las cosas? | 1 | 0 |
| 6 |  En las últimas 2 semanas, ¿cree que su problema de espalda le impedirá hacer su trabajo habitual durante mucho tiempo? | 1 | 0 |
| 7 |  En las últimas 2 semanas, ¿ha pensado que sería mejor que su trabajo habitual fuera más ligero? | 1 | 0 |
| 8 |  En las últimas 2 semanas, ¿su problema de espalda le ha preocupado o ha hecho que piense que no es una persona sana? | 1 | 0 |
| 9 |  En las últimas 2 semanas, ¿su problema de espalda le ha dificultado dormir? | 1 | 0 |
| **PUNTUACIÓN TOTAL** (sume los puntos de los 9 ítems) | | | |

### ¿CÓMO PUNTUAR?

- Cada pregunta se responde con "Sí" o "No".
- Asigne 1 punto por cada respuesta "Sí".
- Asigne 0 puntos por cada respuesta "No".
- Sume los puntos de los 9 ítems para obtener la puntuación total.

### INTERPRETACIÓN DE LA PUNTUACIÓN

**0 – 3 puntos**
**RIESGO BAJO**
Menor probabilidad de discapacidad persistente.

**4 – 6 puntos**
**RIESGO MODERADO (BAJO)**
Probabilidad moderada de discapacidad.

**7 – 8 puntos**
**RIESGO MODERADO (ALTO)**
Mayor probabilidad de discapacidad a mediano plazo.

**9 puntos**
**RIESGO ALTO**
Alta probabilidad de discapacidad persistente y uso de servicios de salud.

**IMPORTANTE**

La escala STarT Back ayuda a identificar el nivel de riesgo de cada paciente para orientar el tratamiento más adecuado y optimizar los recursos.

Fuente: Hill JC et al. A primary care back pain screening tool: identifying patient subgroups for initial treatment. Arthritis Rheum. 2008;59(5):632–641.